

2026

突破时空，健康不再遥远

居家健康管理平台 解决方案

广州圆爱康生物科技有限公司

目录

01 项目背景

02 项目介绍

03 项目应用



01、项目背景

1.1.国家政策-互联网+医疗健康，推进居家医疗康复服务

健康中国2030规划纲要

中共中央、国务院印发《“健康中国2030规划纲要”》

- 1、鼓励创新医疗卫生服务供给模式，完善服务体系。
- 2、大力发展互联网的健康服务模式，高效配置优质医疗资源，从医院、社区到家庭下沉医疗服务，**充分合理利用创新平台提升医疗服务水平。**

国卫老龄发〔2024〕40号

《国家卫生健康委 民政部 国家医保局
国家中医药局、国家疾控局关于促进医养结合服务高质量发展的指导意见》

- 明确要求“发展居家社区医养结合服务”，**支持医疗机构向居家场景延伸（第七条）。**
- 鼓励“推进互联网+医养结合”，允许第三方机构参与信息化建设（第十条）。
- 要求医保部门将居家医疗纳入支付范围（第五条）。

国办发〔2018〕26号

国务院办公厅印发《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》

- 支持医疗机构联合第三方搭建互联网平台（第四条），**允许开展远程医疗、健康管理等服务。**
- 明确“推广智能可穿戴设备”（第十条），为**设备租赁提供依据。**
- 要求建立**“线上线下一体化服务”模式**（第三条），覆盖上门服务场景。

1.1.国家政策-互联网+医疗健康，推进居家医疗康复服务

粤府办〔2018〕22号

广东省人民政府办公厅关于印发广东省促进
“互联网+医疗健康”发展行动计划（2018-
2020年）的通知 粤府办〔2018〕22号

允许医疗机构使用互联网医院作为第二名称，在实体医院基础上，
运用互联网技术提供安全适宜的医疗服务（第二条）

支持医疗卫生机构、符合条件的第三方机构搭建互联网信息平台，
开展远程医疗、健康咨询、健康管理服务（第二条）

支持“互联网+医疗健康”可持续发展要求，及时完善互联网医疗服务价格政策，对基于互联网开展的医疗服务项目，属基本医疗服务的，按基本医疗服务价格项目规范执行，并按规定纳入医保支付范围；对竞争较充分、个性化需求较强的项目，实行市场调节价。（第二条）

运用物联网技术，实现对居民健康的实时监测、疾病预警、慢病筛查、主动干预、个性化评估，支持居民医疗健康信息自主在线查询、居民健康自我管理（第五条）

1.1.国家政策-互联网+医疗健康，推进居家医疗康复服务

国家医保局

2024-11-12

《综合诊查类医疗服务价格项目立项指南（试行）》

15	互联网诊查费（首诊）*	指中级职称及以下医务人员通过互联网医疗服务平台提供技术劳务的首次诊疗服务，包含为患者提供从问诊到诊断，制定诊疗方案或提出下一步诊疗建议。	所定价格涵盖信息核实、在线问诊、记录分析、制定诊疗方案或建议，必要时在线开具处方等所需的人力资源和基本物质资源消耗。	01副主任医师加收 02主任医师加收 03知名专家加收		次	收费范围限国家卫生健康主管部门准许通过互联网方式开展的首诊服务。该项目目前处于未激活状态，待国家卫健委另行规定激活后生效。
16	互联网诊查费（复诊）	指医务人员通过互联网医疗服务平台提供技术劳务的复诊诊疗服务，包含为患者提供从问诊到诊断，制定诊疗方案或提出下一步诊疗建议。	所定价格涵盖信息核实、在线问诊、查阅既往病历及检查报告、记录分析、制定诊疗方案或建议，必要时在线开具处方等所需的人力资源和基本物质资源消耗。			次	1.收费范围限国家卫生健康主管部门准许通过互联网方式开展的复诊服务。 2.公立医疗机构开展互联网复诊，由不同级别医务人员提供服务，均按普通门诊诊查类项目价格收费。
17	远程监测费	指医技人员为院外患者提供的远程监测服务。	所定价格涵盖信息核实、检查设备功能、安置远程监测设备、指导使用、程控打开远程监测设备、数据信息采集、分析判断、结果反馈、提供建议，指导随访等所需的人力资源和基本物质资源消耗。			日	1.具备远程实时监测功能，且实时传输数据至医院端供医生了解病情的装置使用时可收取该项费用。仅具有数据存储功能，不能实时传输数据的设备不得收取此费用。 2.远程监测范围仅限国家卫生健康主管部门准许开展的心电监护、除颤器监护、起搏器监护等项目。

1.2.总结

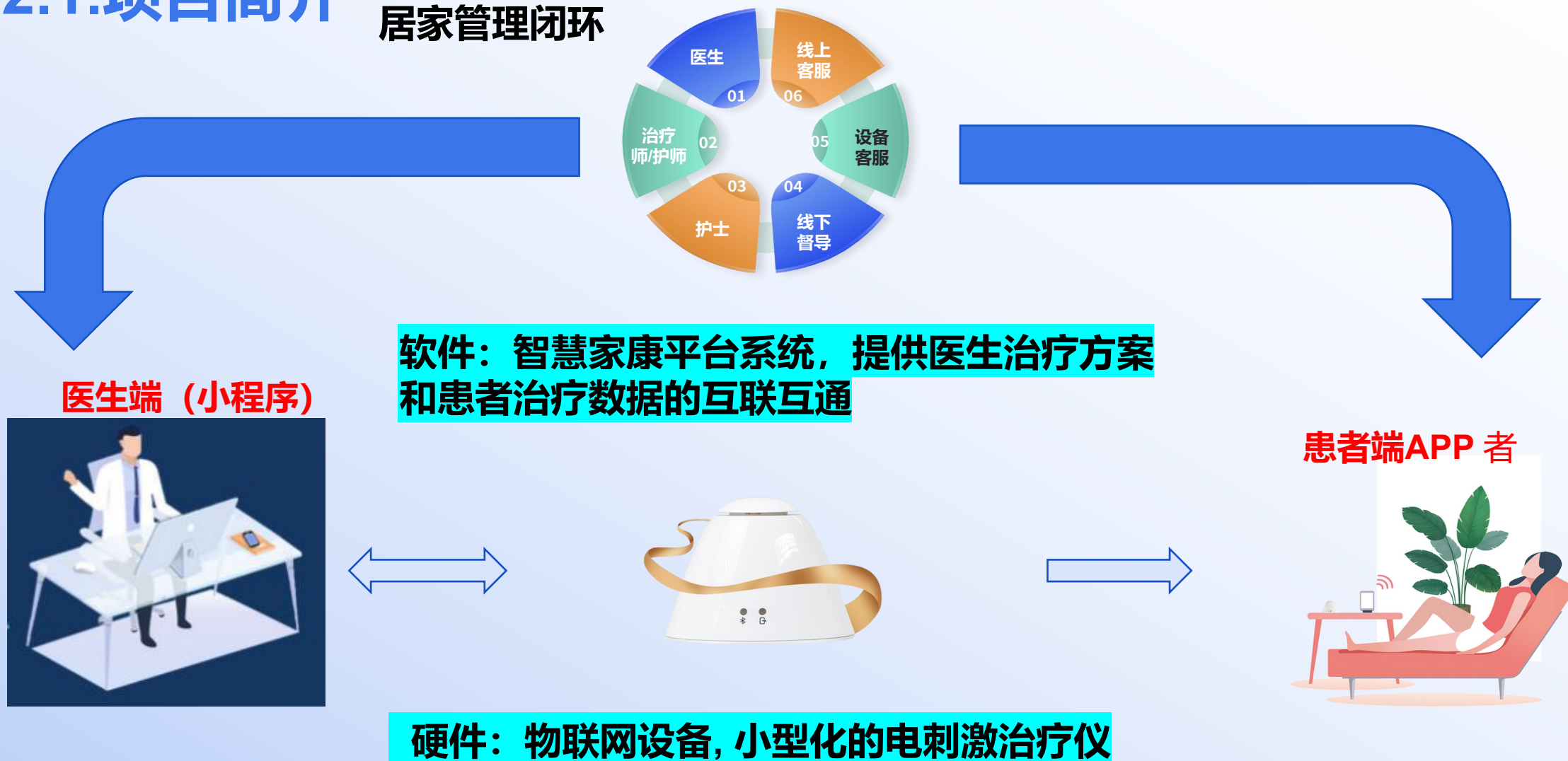
- 综上所述：互联网+医疗健康，是国家医疗健康发展的重要战略，契合目前的医疗现状，能更好的配置医疗资源，提升服务质量，从中共中央/国务院/五部委/广东省各个层面都进行了政策支持；国家医保局对于合规收费也提供了政策依据。



02、项目介绍

2.1.项目简介

居家康复：为患者提供专业医生指导下的康复治疗方案
居家管理闭环



2.2项目优势：

- 1.2.1 患者方面：方便了目前因工作时间、交通等因素无法多次往返医院进行康复治疗的患者，使患者能居家就能完成与医院同质量的电刺激治疗（产后康复、盆底康复、内膜修复、人流康复等、）大大提高了患者的便利性和舒适性。
- 1.2.2 医生方面：能随时在线上对患者疗效进行评估和方案调整，提高患者依从性，达到更好的治疗效果和更舒适的治疗体验。
- 1.2.3 医院方面：不占用资金预算，延伸医院服务空间，提高医院收益

2.3.项目落地模式

项目类别	医 院	“智慧家康”健康管理服务平台
服务落地方式	医院提供医院公众号下的平台搭载条件	“智慧家康”医疗健康服务平台搭载在医院公众号作为医院居家医疗服务模块，对接相关周期性居家健康管理或康复项目，并提供在线支付服务。
服务提供	通过医院医护提供医疗技术支持，服务各类型患者的居家健康管理需求	软件：医疗健康管理服务平台、移动端管理小程序、患者端APP 硬件：物联网居家康复设备及配套耗材 服务：六师共管服务体系支撑，医院到居家的协同医疗服务支撑 物流：物联网设备的往返物流费 检测：物联网设备租赁后的消毒、检测、再包装
收费方式	医院根据收取合理的医疗服务费，以及其他国家政策法规许可的合理收费	协同服务费（含耗材费）
结算方式	医院服务费及“智慧家康”协同服务共同组成健康管理套餐，在医疗健康服务平台统一收款后按双方协议约定结算方式双方进行周期结算。	在医疗健康管理服务平台进行线上结算
项目投入	医院无需做项目资金投入	“智慧家康”所提供的软硬件服务所需资金由项目方自行负责
服务方式	医院有周期性健康或者康复需求的患者，自愿选择在医院公众号下选择购买居家健康服务，由医生通过移动医护管理小程序在线为患者制定治疗方案，进行评估结果的解读、治疗方案的调整等，并通过“智慧家康”“六师共管”的N对一服务，医护参与患者居家康复期间的健康指导及医疗咨询服务。	患者在线购买居家健康服务后，通过“六师共管”服务体系，建立以专科医生、康复师、护士、“智慧家康”线上客服、设备工程师和线下督导为主体的共管服务群，为居家患者不同的需求提供专业服务。“智慧家康”客服主要对接非医疗技术部分的服务。

2.4.招标模式说明

把智慧家康平台作为第三方平台嵌入医院互联网医院

珠海市妇幼保健院互联网+智慧医疗康复服务项目采购信息公告

2025-11-27 浏览量：111

一、采购编号：FYZC〔2025〕020

二、项目基本信息：

（一）项目名称：珠海市妇幼保健院互联网+智慧医疗康复服务采购项目

（二）预算金额：/

（三）采购方式：简易采购

（四）采购需求：

1. 标的情况：

采购内容	服务期限	技术规格、参数及要求	费率最低限价（%）	备注
互联网+智慧医疗康复服务	2年	详见采购文件	45%	医院收取的管理费率不低于总收取套餐费用的45%。

注：供应商的响应报价不得低于该项目最低限价，否则将被认定为无效响应。

2.4.招标模式说明

居家项目作为服务项目引入医院

盆底康复居家项目第三方服务采购公告

发布时间: 2025-10-24 17:09:54 发布人: 招标采购办公室

我要报名

根据医院发展需要,结合医院实际,拟对医院盆底康复居家项目第三方服务进行采购。欢迎具有相关资质的公司报名。

一、项目情况:

采购内容	服务期	最高限价(元)
南方医科大学第八附属医院盆底康复居家项目第三方服务	2年	人民币98万元

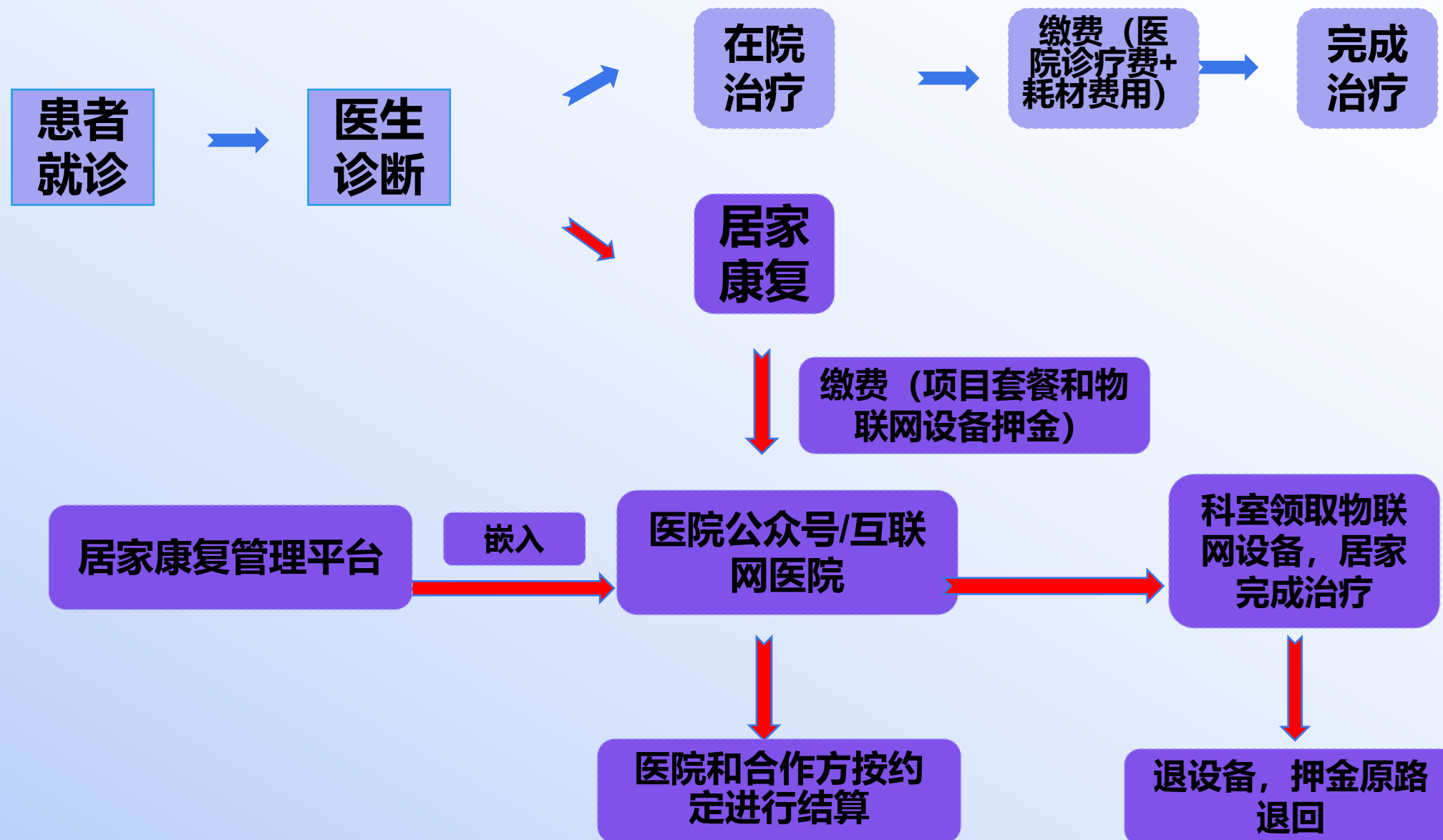
备注: 1. 该项目预算价为最高限价,超过预算价的报价为无效报价。

2. 项目具体内容及需求详见:盆底康复居家项目第三方服务需求书。

二、供应商资格条件

1. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件;
2. 必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织;
3. 营业执照经营范围:满足本项目内容;
4. 本项目不接受联合体参与,不得转包或分包。

2.5.项目流程简述（示意图）





03、项目应用

3.1.项目应用场景

• 中重度宫腔粘连术后内膜修复

表 1 两组治疗前后子宫内膜厚度、AFS 评分、月经量评分以及复发率比较

Table 1 Comparison of endometrial thickness, AFS score, menstrual score, and recurrence rate between the two groups before and after treatment $[(\bar{x} \pm s) \text{ or } M(P_{25} \sim P_{75}) \text{ or } n(\%)]$

Variables	Experimental group (n=50)	Control group (n=57)	t/Z/ χ^2	P
Endometrium thickness/mm				
Before	4.43±1.69	4.16±1.76	0.820	0.414
After	6.62±1.70	5.55±1.75	3.187	0.002
Difference	2.19±1.69	1.39±1.63	2.472	0.015
AFS score				
Before	10 (8~10)	10 (8~10)	-0.262	0.793
After	1 (0~3.25)	4 (0~4)	-0.699	0.007
Difference	8 (6~9)	6 (4~8)	-3.156	0.002
Menstrual score				
Before	50 (30~70)	40 (30~60)	-0.885	0.376
After	80 (60~90)	60 (60~80)	-2.634	0.008
Difference	20 (10~30)	20 (10~30)	-0.699	0.484
Recurrence				
Recurrence of adhesion	11 (22.0%)	25 (43.9%)		0.017
No recurrence of adhesion	39 (78.0%)	32 (56.1%)		

第 43 卷 第 1 期

中山大学学报(医学科学版)

Vol.43 No.1

2022 年 1 月

JOURNAL OF SUN YAT-SEN UNIVERSITY(MEDICAL SCIENCES)

January 2022

·临床研究·

盆底神经肌肉电刺激治疗对中重度宫腔粘连术后子宫内膜修复的疗效评估

刘晓丹¹, 冯洁玲², 王嘉敏¹, 杨国霞¹, 陈玉清¹

(1. 中山大学附属第一医院妇产科, 广东 广州 510080; 2. 中山大学附属第一医院超声科, 广东 广州 510080)

摘要:【目的】探讨盆底低频神经肌肉电刺激治疗对中重度宫腔粘连术后子宫内膜修复的疗效。【方法】前瞻性收集 2019 年 12 月至 2020 年 12 月期间确诊为中重度宫腔粘连并接受治疗的 107 例患者的临床资料。根据患者的意愿分为实验组(盆底治疗组, 50 例)和对照组(常规治疗组, 57 例)。所有患者均行宫腔镜下宫腔粘连电切分离术(TCRA)。对照组行 TCRA 后予雌激素为主的人工周期治疗。实验组行 TCRA 后予盆底低频神经肌肉电刺激联合人工周期治疗, 治疗期间进行每天 30 min 的间歇性阴道电刺激。比较两组患者的粘连复发率、治疗前后子宫内膜厚度等临床预后。检测治疗前后两组患者子宫内膜中 VEGF 的表达水平。【结果】实验组宫腔粘连治疗后复发率为 22.0%, 显著低于对照组的 43.9% ($P=0.017$)。实验组治疗后子宫内膜厚度增加 (2.19 ± 1.69) mm 较对照组 (1.39 ± 1.63) mm 显著 ($P=0.015$)。实验组治疗后子宫内膜中 VEGF 的平均光密度值(AOD)表达上调 0.05 ($0.03 \sim 0.08$) 较对照组 0.03 ($0.01 \sim 0.04$) 明显 ($P=0.000$)。【结论】盆底低频神经肌肉电刺激治疗能有效降低中重度宫腔粘连患者术后复发率, 对促进血管生成, 增加子宫内膜厚度有显著疗效。|

关键词: 盆底神经肌肉电刺激; 宫腔粘连; 子宫内膜

中图分类号: R711.7

文献标志码: A

文章编号: 1672-3554(2022)01-0140-06

DOI: 10.13471/j.cnki.j.sun.yat-sen.univ(med.sci).2022.0117

3.2.项目应用场景

• 人流术后内膜修复

2 结果

2.1 比较两组管理前后子宫内膜厚度

相比参照组,观察组经过居家康复管理后子宫内膜厚度更厚($P<0.05$)。见表1。

表1 比较两组管理前后子宫内膜厚度 (mm, $\bar{x}\pm s$)

项目	例数	管理后
参照组	61	5.78 ± 0.54
观察组	56	6.64 ± 0.85
t		6.466
P		<0.001

2.2 比较人流术后并发症发生情况

相比参照组人流术后并发症发生率(14.75%),观察组发生率(1.79%)更低($\chi^2=6.282, P=0.012<0.05$)。见表2。

表2 比较人流术后并发症发生情况 [n(%)]

组别	例数	恶心呕吐	腹痛腹胀	宫腔粘连	发生率
参照组	61	4	3	2	9(14.75)
观察组	56	1	0	0	1(1.79)

基于互联网医疗的居家康复管理对人流术后子宫内膜修复的影响

卢建娣,刘韦伟,池苗,陈红霞

广东省珠海市妇幼保健院 南琴院区妇科门诊(广东 珠海 519000)

(内文见下页)

摘要 目的:探究基于互联网医疗的居家康复管理对人流术后子宫内膜修复的影响。方法:收集2023年5月至2024年5月期间在广东省珠海市妇幼保健院接受人工流产术的非意愿妊娠女性患者117例,按照随机数字表法分为参照组($n=61$)与观察组($n=56$)。参照组给予术后西药+常规延续管理;观察组在参照组方案基础上给予基于互联网医疗的居家康复管理。持续管理2个月,比较两组管理后子宫内膜厚度;比较两组人流术后并发症发生情况。结果:相比参照组,观察组经过居家康复管理后子宫内膜厚度更厚($P<0.05$)。相比参照组人流术后并发症发生率(14.75%),观察组发生率(1.79%)更低($P<0.05$)。结论:对人流术后女性患者居家期间实施基于互联网医疗的居家康复管理,有利于子宫内膜修复,避免术后并发症发生,值得推广研究。

关键词:人工流产术;居家康复;子宫内膜修复;互联网医疗

中图分类号:R714.21 文献标识码:A 文章编号:1006-2882(2025)01-227-04

DOI:10.14035/j.cnki.hljyy.2025.01.080

3.3.项目应用场景

• 薄型子宫内膜修复

表1 仿生物电刺激前后子宫内膜厚度、血流灌注比较

组别	内膜厚度	RI	PI	S/D
治疗前	6.54 ± 0.25	0.52 ± 0.04	0.71 ± 0.052	2.31 ± 0.150
治疗后	7.46 ± 0.72	0.47 ± 0.05	0.67 ± 0.032	2.18 ± 0.172
t值	-5.807	2.784	2.448	2.511
P值	0.000	0.009	0.019	0.017

临床论著

Original Research

仿生物电刺激改善薄型子宫内膜厚度及血流灌注的研究*

胡 艳 光晓燕 李 环 张巍颖 魏蔚霞 王丽平 付 敏

北京大学深圳医院妇产科, 广东 深圳 518036

【摘要】目的 探讨仿生物电刺激对薄型子宫内膜治疗的疗效。方法 选择23例薄型子宫内膜患者作为研究对象, 对所有患者均采用仿生物电刺激技术进行治疗, 比较治疗前后患者子宫内膜厚度、子宫内膜(下)动脉阻力指数(RI), 搏动指数(PI)、血流收缩期最高血流速度(S)/舒张期末血流速度(D)比值。结果 经仿生物电刺激治疗后薄型子宫内膜患者子宫内膜厚度和血流灌注均较前增加, 差异具有统计学意义($P < 0.05$)。结论 仿生物电刺激能增加薄型子宫内膜厚度和提高内膜血流灌注, 从而提高子宫内膜的容受性; 值得临床推广应用。

【关键词】薄型子宫内膜; 子宫内膜容受性; 仿生物电刺激

【基金项目】深圳市科技局课题(项目编号: 201103011)

【中图分类号】R71; R3

【文献标识码】A

doi:10.3969/j.issn.1009-3257.2013.06.005



让我们用心呵护您的健康

智慧家康